Analyse 3 — Accès aux services de santé et chocs sanitaires des ménages

RIRADJIM NGARMOUNDOU TRESOR ET GUEBEDIANG A NKEN KADIDJA

17 March 2026

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Données mobilisées **2**

3 Méthodologie et traitement des valeurs manquantes **2**

4 Morbidité par sexe et groupe d'âge **3**

5 Types de maladies déclarées **4**

6 Prestataires consultés **5**

7 Distribution des dépenses de santé **6**

8 Dépenses selon le type de prestataire **6**

9 Recours aux soins selon le quintile de consommation **7**

10 Dépenses de santé selon le quintile de consommation **9**

11 Dépenses de santé en milieu rural et urbain **9**

12 Discussion générale **10**

13 Conclusion **11**

1 Introduction

L'accès aux services de santé constitue une dimension centrale du bien-être des ménages. Dans les contextes où la couverture sanitaire reste incomplète, les épisodes de maladie peuvent entraîner à la fois des difficultés d'accès aux soins et des charges financières importantes.

Cette étude analyse l'accès aux soins des ménages nigérians à partir de la vague 4 du **Nigeria GHS Panel**. L'objectif est de décrire la morbidité déclarée, les types de prestataires consultés, les dépenses de santé supportées par les ménages, puis d'examiner les inégalités selon le sexe, l'âge, le milieu de résidence et le niveau de consommation.

2 Données mobilisées

L'analyse repose sur les fichiers suivants :

- `sect1_harvestw4.dta` pour les caractéristiques individuelles ;
- `sect4a_harvestw4.dta` pour les variables de santé, de recours aux soins et de dépenses ;
- `totcons_final.dta` pour la mesure du niveau de consommation et la construction des quintiles.

Une exploration préalable des fichiers a montré que, dans les données effectivement disponibles, les variables de santé pertinentes sont stockées dans `sect4a_harvestw4.dta`. L'analyse a donc été conduite à partir des fichiers réellement cohérents avec le contenu attendu, même si l'énoncé mentionnait d'autres références.

La base analytique finale contient **26 556** observations.

3 Méthodologie et traitement des valeurs manquantes

Les valeurs manquantes n'ont pas conduit à une suppression globale de la base. Une exclusion ciblée a été appliquée selon les besoins propres à chaque analyse. Ainsi :

- l'analyse de la morbidité utilise seulement les observations avec `malade`, `sexe` et `age_groupe` renseignés ;
- l'analyse des maladies déclarées repose sur les individus ayant au moins un type de maladie renseigné ;
- l'analyse des prestataires conserve les observations avec `prestataire_1` non manquant ;
- les graphiques de dépenses en échelle logarithmique utilisent uniquement les dépenses strictement positives ;
- le test recours aux soins × quintile utilise seulement les observations pour lesquelles `consulte` et `quintile_conso` sont renseignés.

Table 1: Effectifs utilisables selon l'analyse

analyse	n_utilisable
Base totale	26556
Morbidité (malade + sexe + âge_groupe)	22171
Types de maladies	6450
Prestataires consultés	6450
Dépenses de santé	8624
Dépenses par milieu	8624
Consultation x quintile	26533

Table 2: Variables les plus touchées par les valeurs manquantes

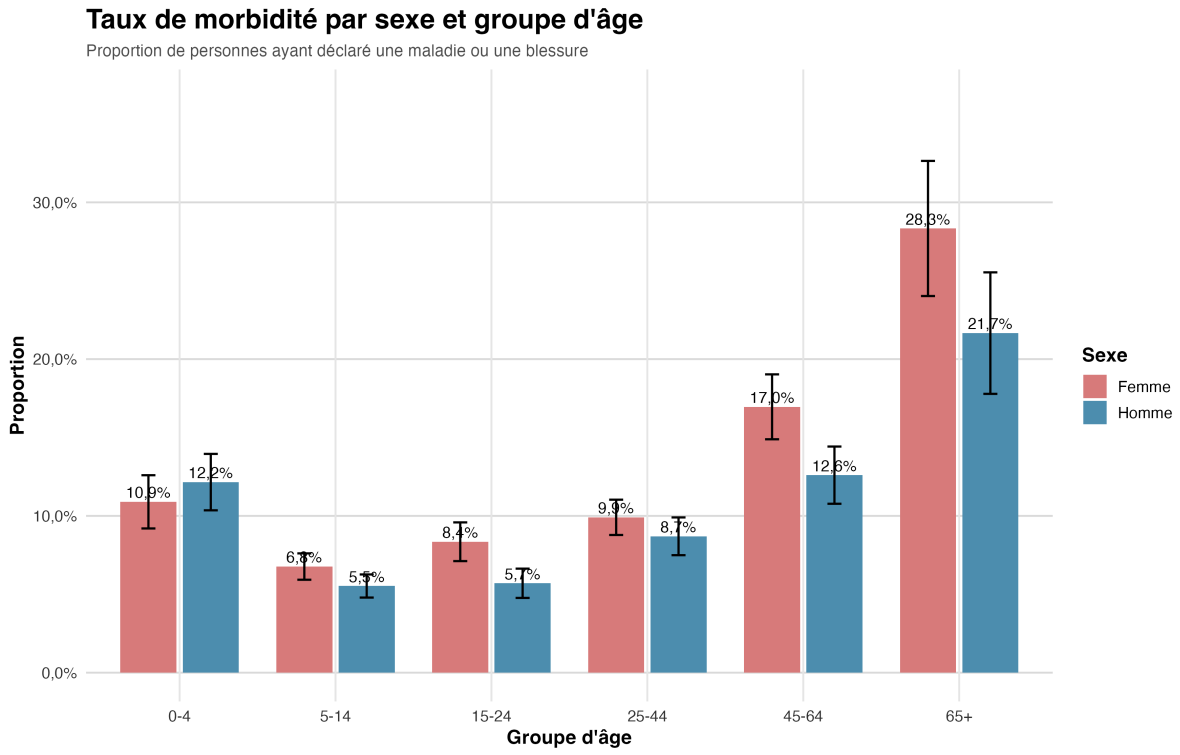
variable	n_missing	pct_missing	n_non_missing
prestataire_2	26100	98.28	456
dep_hospit	25733	96.90	823
type_maladie_2	24224	91.22	2332

variable	n_missing	pct_missing	n_non_missing
type_gestion	21484	80.90	5072
dep_transport	21227	79.93	5329
lieu_consult	21018	79.15	5538
dep_consult	21018	79.15	5538
type_maladie_1	20106	75.71	6450
prestataire_1	20106	75.71	6450
dep_medic	18632	70.16	7924

4 Morbidité par sexe et groupe d'âge

L'analyse de la morbidité a été réalisée sur **22 171** observations exploitables. Les résultats montrent que la probabilité de déclarer une maladie ou une blessure augmente avec l'âge. Le niveau le plus élevé est observé chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Les différences entre femmes et hommes restent modérées dans les premiers groupes d'âge, mais deviennent plus visibles à l'âge adulte et aux âges avancés. Dans plusieurs classes d'âge, les femmes déclarent une morbidité plus forte que les hommes.



Cette structure suggère un **gradient croissant de morbidité avec l'âge**, particulièrement marqué chez les personnes âgées.

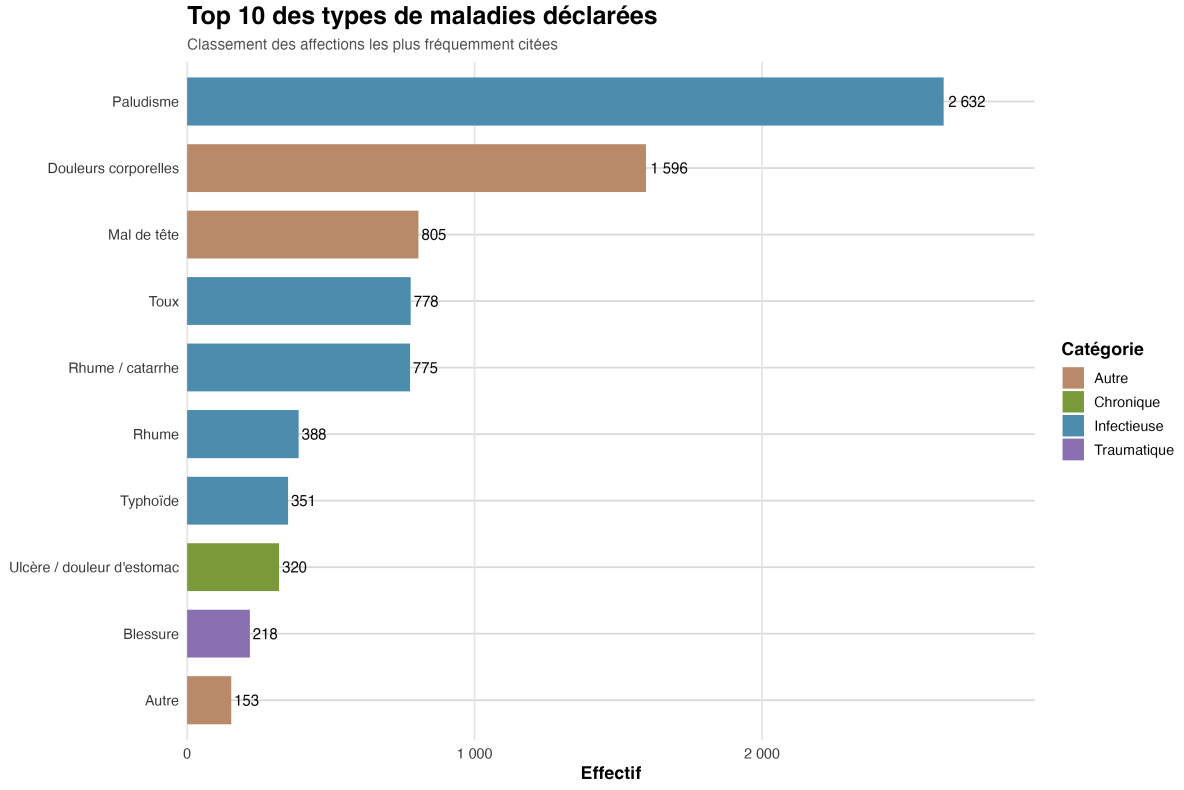
Table 3: Morbidité selon le sexe et le groupe d'âge

sexe	age_groupe	n	cas	prop	se	low	high
Femme	0-4	1294	141	0.1089645	0.0086621	0.0919868	0.1259422
Homme	0-4	1267	154	0.1215470	0.0091800	0.1035541	0.1395398
Femme	5-14	3428	232	0.0676779	0.0042903	0.0592690	0.0760869
Homme	5-14	3691	204	0.0552696	0.0037612	0.0478976	0.0626415
Femme	15-24	1928	161	0.0835062	0.0063004	0.0711574	0.0958551
Homme	15-24	2368	135	0.0570101	0.0047647	0.0476713	0.0663490
Femme	25-44	2705	268	0.0990758	0.0057444	0.0878168	0.1103348
Homme	25-44	2104	183	0.0869772	0.0061436	0.0749358	0.0990186
Femme	45-64	1262	214	0.1695721	0.0105633	0.1488681	0.1902761
Homme	45-64	1270	160	0.1259843	0.0093114	0.1077339	0.1442346
Femme	65+	420	119	0.2833333	0.0219879	0.2402371	0.3264295
Homme	65+	434	94	0.2165899	0.0197728	0.1778351	0.2553446

5 Types de maladies déclarées

L'analyse des types de maladies porte sur **6 450** observations exploitables. La maladie la plus fréquemment déclarée est **Paludisme**, avec environ **2 632** cas.

Les premières positions du classement sont dominées par le paludisme, les douleurs corporelles, les maux de tête et plusieurs affections respiratoires. Dans l'ensemble, les maladies infectieuses occupent une place centrale, ce qui est cohérent avec le contexte épidémiologique étudié.



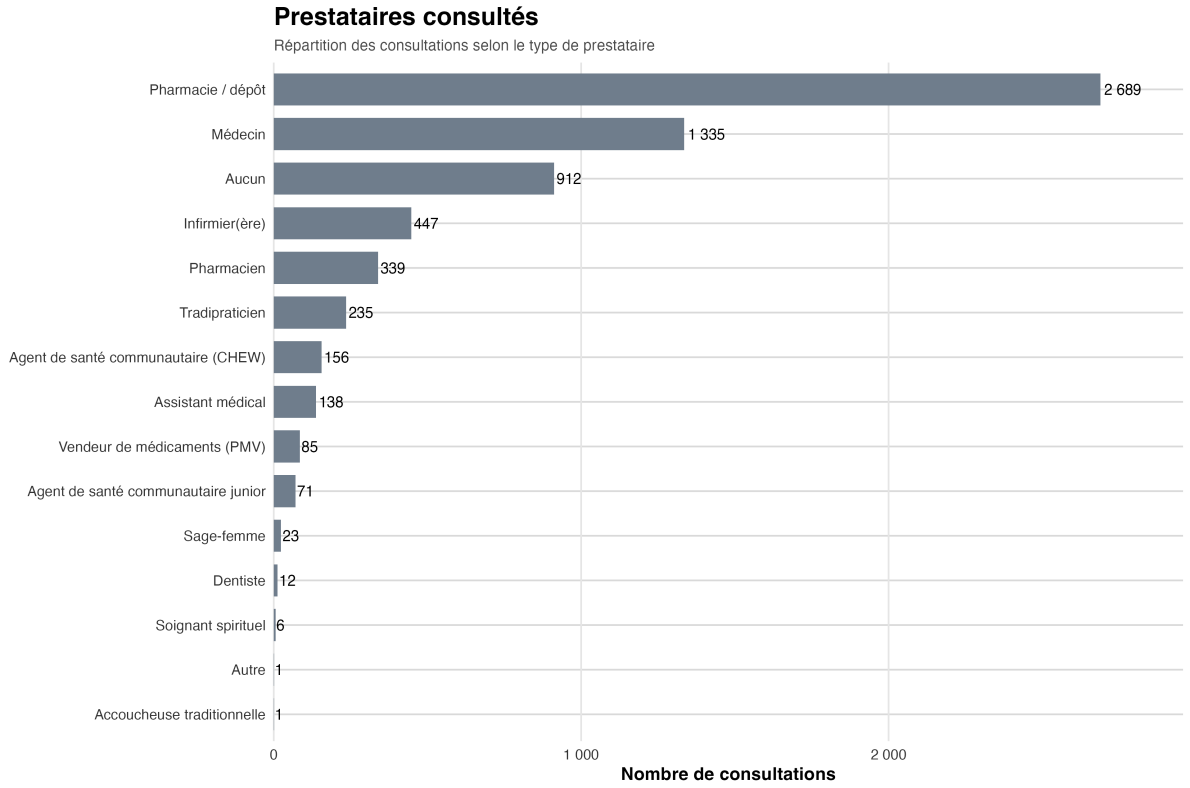
La structure observée reflète donc un profil sanitaire dominé par les **affections infectieuses et les troubles fréquents du quotidien**.

Table 4: Top 10 des maladies déclarées

maladie	categorie	n
Paludisme	Infectieuse	2632
Douleurs corporelles	Autre	1596
Mal de tête	Autre	805
Toux	Infectieuse	778
Rhume / catarrhe	Infectieuse	775
Rhume	Infectieuse	388
Typhoïde	Infectieuse	351
Ulcère / douleur d'estomac	Chronique	320
Blessure	Traumatique	218
Autre	Autre	153

6 Prestataires consultés

L'analyse du recours aux prestataires repose sur **6 450** observations exploitables. Le principal prestataire observé est **Pharmacie / dépôt**, avec **2 689** consultations.

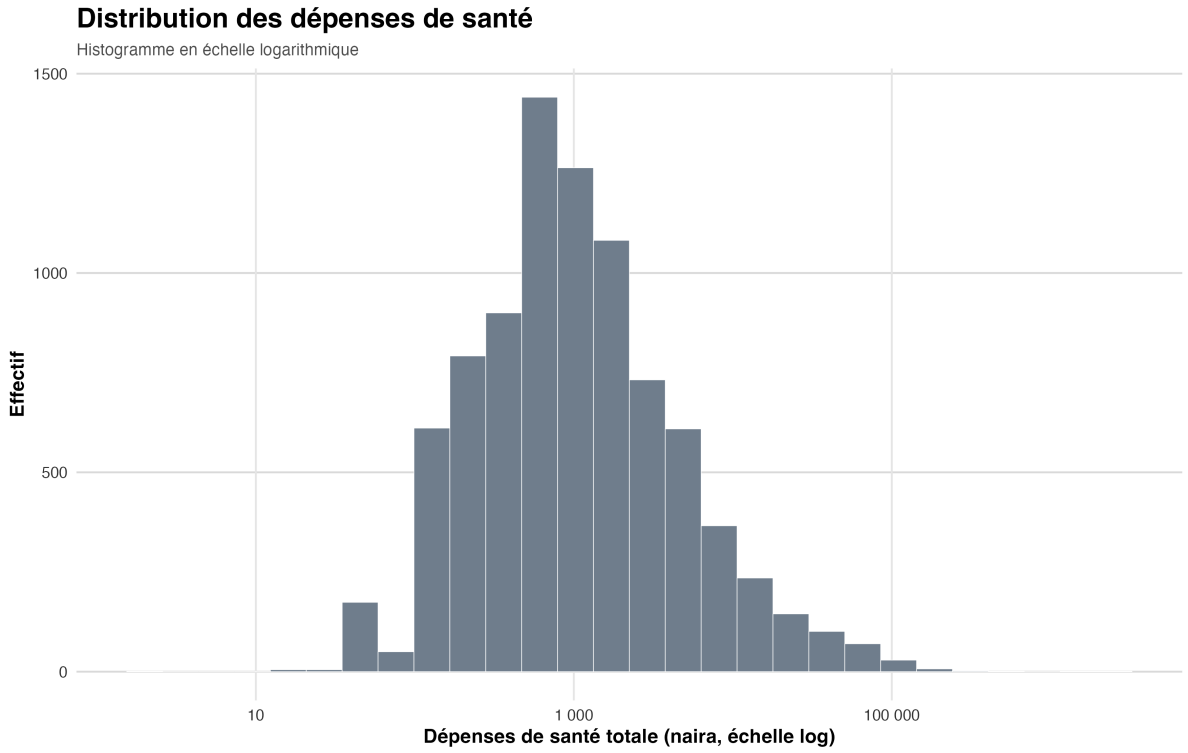


Les pharmacies et dépôts de médicaments occupent une place centrale dans le recours aux soins. Les médecins arrivent ensuite, tandis qu'une part non négligeable des individus ne consulte aucun

prestataire. Cette structure suggère un système de recours aux soins dans lequel les points de soins de proximité jouent un rôle majeur.

7 Distribution des dépenses de santé

L'analyse des dépenses de santé repose sur **8 624** observations avec dépenses positives. La distribution est fortement asymétrique. La médiane est d'environ **900** nairas, tandis que le neuvième décile atteint environ **7 100** nairas.



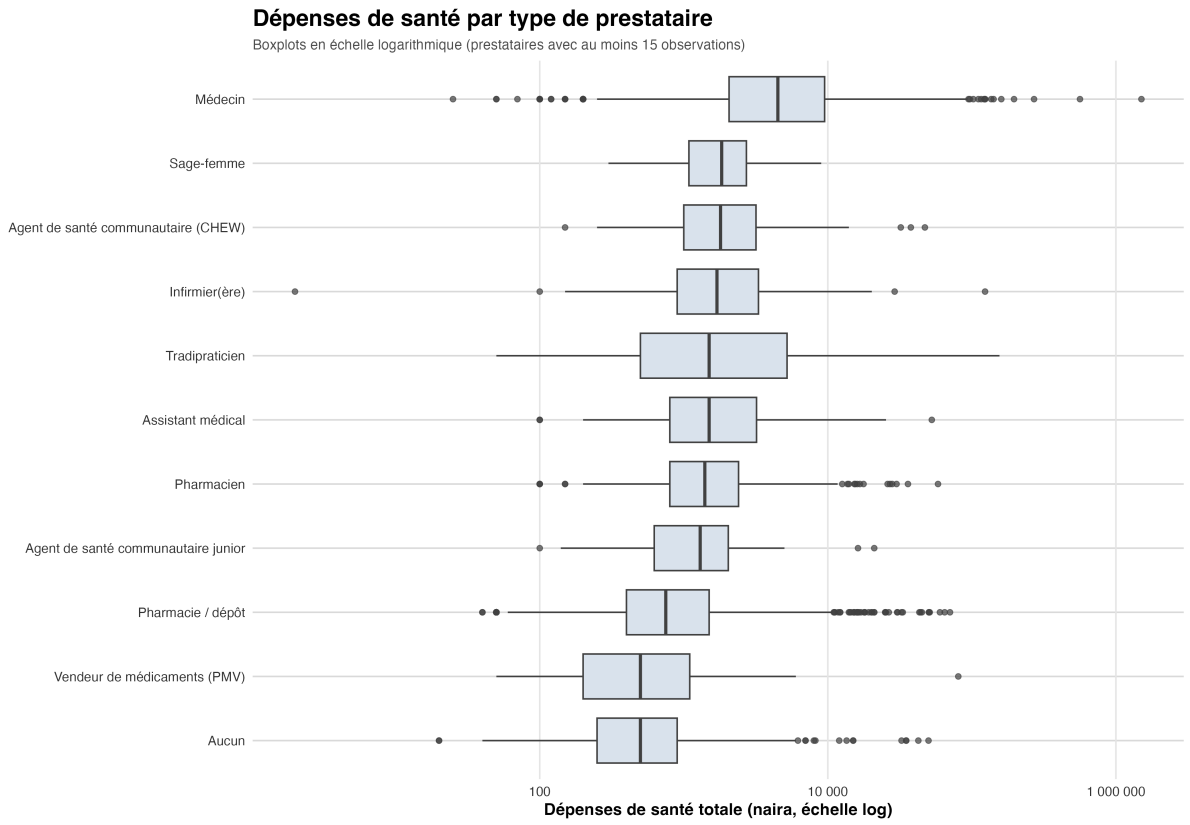
L'histogramme en échelle logarithmique confirme que la majorité des dépenses se concentre à des niveaux relativement faibles, mais qu'un petit nombre d'observations présente des montants très élevés.

Table 5: Déciles des dépenses de santé

d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
180	300	500	600	900	1300	2000	3350	7100

8 Dépenses selon le type de prestataire

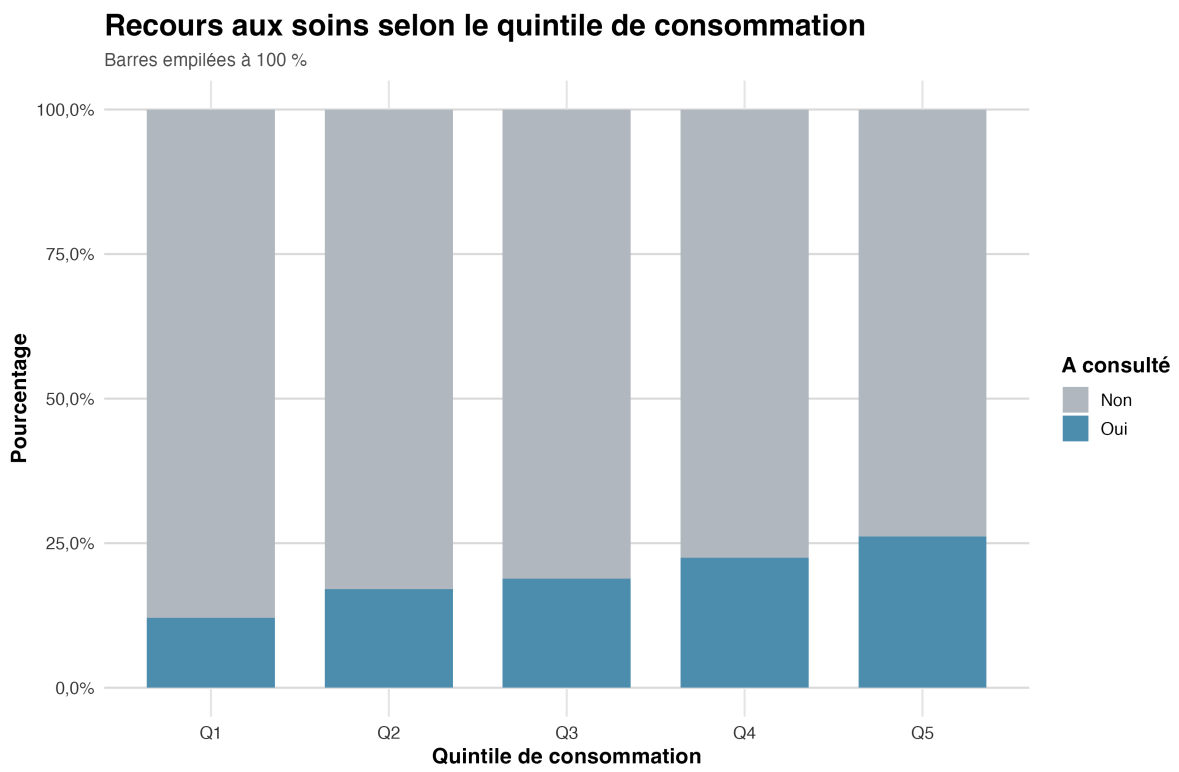
Les dépenses diffèrent selon le prestataire consulté. Les consultations associées aux médecins présentent des dépenses médianes plus élevées que celles observées pour les pharmacies et vendeurs de médicaments. Les prestataires informels apparaissent également dans des zones de dépenses plus faibles, bien que les dispersions restent importantes.



Le graphique montre aussi l'existence de valeurs extrêmes dans plusieurs catégories, ce qui confirme la forte hétérogénéité des dépenses.

9 Recours aux soins selon le quintile de consommation

Le test de dépendance entre recours aux soins et quintile de consommation a été réalisé sur **26 533** observations exploitables. Le barplot empilé à 100 % montre une progression nette du recours aux soins lorsque l'on passe des quintiles les plus pauvres aux quintiles les plus riches.



Dans les quintiles faibles, la part des individus ayant consulté reste limitée. Elle augmente progressivement et atteint son niveau le plus élevé dans le quintile supérieur. Cela suggère que les contraintes économiques influencent le recours effectif aux services de santé.

Table 6: Tableau de contingence : consultation × quintile de consommation

...1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Non	6989	5171	4184	3285	2183
Oui	961	1062	973	951	774

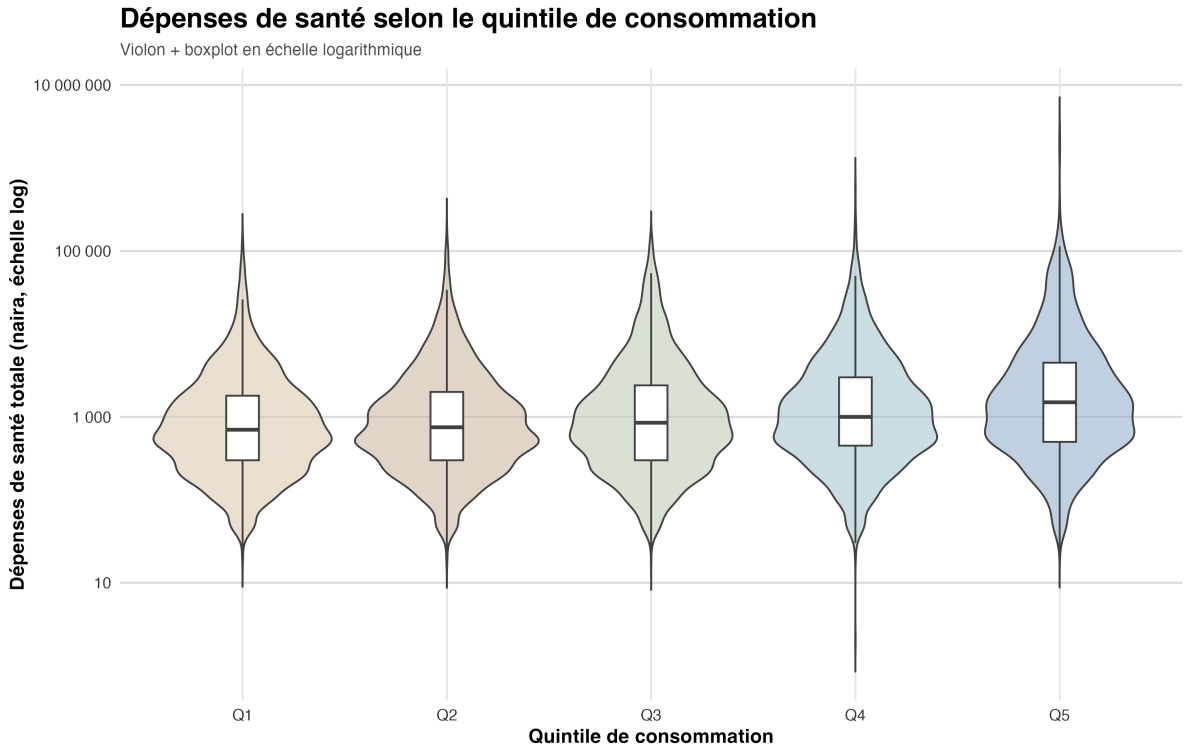
Table 7: Résultats des tests d'indépendance

test	statistic	p_value	note
Chi-deux	388.2503769	0	Toujours calculé
Fisher exact	NA	NA	Non nécessaire
V de Cramér	0.1209658	NA	Mesure de l'intensité de l'association

Le test du chi-deux met en évidence une association statistiquement significative entre le recours aux soins et le quintile de consommation (**p-value = 9.612032e-83**). La valeur du **V de Cramér** (**0.121**) indique une association d'intensité modérée.

10 Dépenses de santé selon le quintile de consommation

Le violin plot des dépenses selon le quintile de consommation montre que la distribution des dépenses se déplace progressivement vers le haut lorsque le niveau de consommation augmente. Les quintiles supérieurs présentent également une dispersion plus forte.



Ces résultats suggèrent que les ménages les plus aisés sont non seulement plus susceptibles de consulter, mais aussi capables de supporter des dépenses de santé plus élevées.

11 Dépenses de santé en milieu rural et urbain

La comparaison des dépenses entre zones rurales et urbaines ne met pas en évidence de différence médiane statistiquement significative. Les distributions restent proches, même si la dispersion semble légèrement plus forte en zone urbaine.

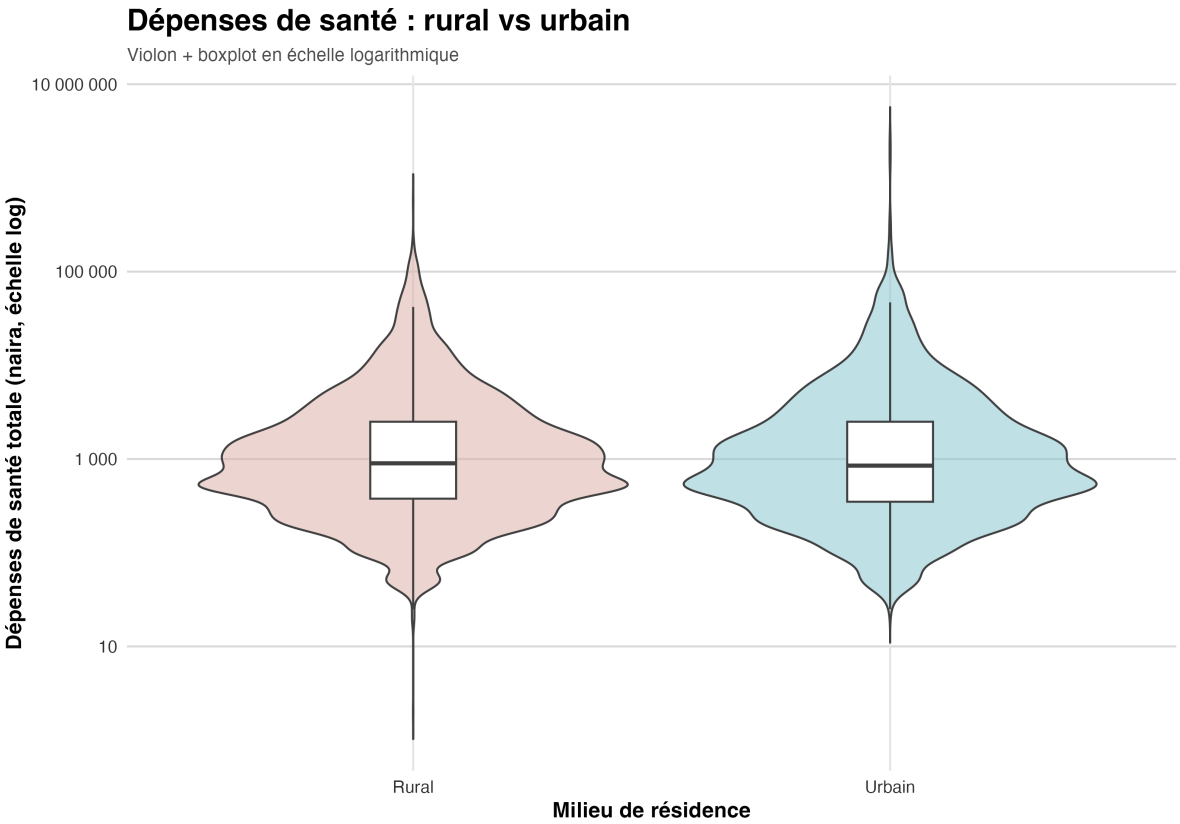


Table 8: Test de Wilcoxon : dépenses rurales vs urbaines

test	statistic	p_value
Wilcoxon rang-sum	7833538	0.8794779

Le test de Wilcoxon conduit à une p-value de **0.8795**, ce qui ne permet pas de conclure à une différence statistiquement significative entre les deux milieux.

12 Discussion générale

L'ensemble des résultats met en évidence plusieurs faits stylisés. D'abord, la morbidité augmente avec l'âge, avec une vulnérabilité particulièrement marquée chez les personnes âgées. Ensuite, les maladies infectieuses, et surtout le paludisme, dominent largement la structure des affections déclarées.

Par ailleurs, les pharmacies et dépôts de médicaments constituent le principal point de recours aux soins. Cette réalité souligne le rôle central des soins de proximité dans un contexte où l'accès au système médical formel peut rester contraint.

Enfin, les résultats montrent des **inégalités économiques nettes** dans l'accès aux soins. Les ménages des quintiles supérieurs consultent davantage et supportent des dépenses plus élevées. Le niveau de consommation apparaît donc comme un déterminant important du recours aux services de santé.

13 Conclusion

Cette analyse confirme que l'accès aux soins au Nigeria dépend à la fois du profil sanitaire des individus et de leur position économique. La morbidité augmente avec l'âge, les maladies infectieuses dominent, et les pharmacies jouent un rôle majeur dans le système de recours. Les dépenses de santé sont très dispersées, avec une forte asymétrie et des valeurs extrêmes.

L'un des résultats les plus importants est l'existence d'un **gradient social d'accès aux soins** : plus le niveau de consommation augmente, plus la probabilité de consulter et le niveau de dépense tendent à augmenter. Ces résultats plaident en faveur d'une attention particulière aux barrières économiques d'accès aux soins dans les politiques publiques de santé.